

Pięć domen *SCAMP*

Co podtrzymuje dłubanie u Ciebie? Model ComB (Mansueto) — pięć czynników: sensoryczny, poznawczy, afektywny, motoryczny, miejscowy. Twój profil = klucz do leczenia.

CZAS: 15–20 min · analiza funkcjonalna Po podstawowej psychoedukacji

ŹRÓDŁO: Mansueto i in. (1997, ComB); Falkenstein & Haaga (2014); TLC Foundation

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **cykl podtrzymujący** dłubanie (sekcja 1), zrozum **pięć domen SCAMP** (sekcja 2). W sekcji 3 wypełnij **swój profil** — które domeny są u Ciebie najsilniejsze.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Mansueto, Stemberger, Thomas i Golomb (1997) opracowali model ComB (*Comprehensive Behavioral*) na podstawie obserwacji, że **generic HRT** nie działa u wszystkich pacjentów. Każda osoba z dermatillomanią ma *indywidualny profil* — u jednej dominuje komponent sensoryczny, u drugiej afektywny, u trzeciej miejscowy. Analiza funkcjonalna w pierwszych 1–2 sesjach **znacząco poprawia** wyniki leczenia (Falkenstein & Haaga, 2014) — bo interwencje celują w *faktyczne* mechanizmy, a nie generyczne wzorce. „*Twój profil*” zamiast „*protokół dla wszystkich*”.

01 ☉ Cykl podtrzymujący dłubanie

Dłubanie nie jest „*nawykiem znikąd*” — funkcjonuje jako element samonapędzającej się pętli. Zrozumienie cyklu jest pierwszym krokiem do jego przerywania w wielu miejscach jednocześnie.

1. Wyzwalacz — stres, nuda, napięcie, „*niedoskonałość*” skóry → **2. Dłubanie** — automatyczne lub świadome → **3. Krótkotrwała ulga** — redukcja napięcia, „*satysfakcja*” → **4. Konsekwencje** — uszkodzenia, wstyd, ukrywanie → **5. Więcej stresu** → powrót do 1.

Punkty interwencji: każdy z pięciu kroków daje możliwość przerywania cyklu. Krok 1 — kontrola bodźców. Krok 2 — trening świadomości i reakcja konkurencyjna (HRT). Krok 3 — alternatywne strategie regulacji. Im więcej miejsc cyklu zaopiekujesz, tym łatwiej go przerwać.

02 📄 Pięć domen SCAMP (Mansueto, 2016)

S · SENSORYCZNE

Potrzeba *czucia*: dotykowo (szukanie nierówności, strupów), wzrokowo (sprawdzanie w lustrze), interoceptywnie („*coś tam jest*”). Skóra szuka stymulacji.

C · POZNAWCZE (COGNITIVE)

Myśli: „*muszę to wycisnąć*”, „*jak usunę — będzie gładko*”, „*jeszcze tylko to jedno*”. Perfekcjonizm skórny — skóra *musi* być idealna.

A · AFEKTYWNE

Emocje: *przed* — lęk, napięcie, nuda, frustracja. *Podczas* — ulga, „*trans*”, odcięcie. *Po* — wstyd, samokrytyka.

M · MOTORYCZNE

Ruch ręki do twarzy/ramienia — automatyczny, w tle innej czynności. Dłubanie podczas TV, czytania, pracy przy biurku. Czysty nawyk ruchowy.

P · MIEJSCOWE (PLACE)

Konkretne miejsca i konteksty: łazienka przed lustrem, łóżko wieczorem, samochód w korku, biurko podczas pracy. Środowisko jako wyzwalacz — często niedoceniany komponent.

03 Mój profil — które domeny są u mnie najsilniejsze

Oceń każdą domenę w skali 0–10. Następnie zidentyfikuj **top 2–3** — to one będą priorytetem leczenia. Większość osób ma 2–3 dominujące domeny + 1–2 słabsze. To wskazuje, które techniki będą działać u Ciebie najlepiej.

S • SENSORYCZNE

— jak silnie szukam dotyku/widoku nierówności? (0–10)

C • POZNAWCZE

— jak silne są myśli „muszę to wycisnąć”? (0–10)

A • AFEKTYWNE

— jak często dłubię w stresie/nudzie? (0–10)

M • MOTORYCZNE

— jak często ręka „sama” idzie? (0–10)

P • MIEJSCOWE

— jak silnie konkretne miejsca/sytuacje wyzwalają? (0–10) + lista hot spots

04 Moje top 2–3 domeny do pracy

TOP DOMENA #1

— najsilniejsza, od niej zaczynam

TOP DOMENA #2

— druga w kolejności

Klucz: model ComB **radykalnie zmienia** sposób leczenia BFRB — od generyczne „jednego protokołu dla wszystkich” do *personalizowanej terapii* dopasowanej do Twojego profilu. Falkenstein & Haaga (2014): pacjenci, którzy przeszli analizę ComB przed wyborem strategii, mieli istotnie lepsze wyniki niż ci, którzy zaczęli generic HRT. **Praktyczna wskazówka:** przez najbliższy tydzień prowadź *dziennik 5-kolumnowy* (po jednej kolumnie na każdą domenę SCAMP). Każdy epizod dłubania zaznacz w odpowiednich kolumnach. Po 7 dniach wzorce stają się *jasne* — widać, które domeny dominują. To podstawa do wyboru technik z kolejnych handoutów (HRT, kontrola bodźców, uważność, stymulacje sensoryczne, praca poznawcza).